Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 06

Hérnias e Parede Abdominal

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Não é referência bibliográfica

Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.

Hérnias e parede abdominal

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Vasos epigástricos separam direta de indireta; femoral e hérnia na mulher (fora da gestação) se operam; homem pouco sintomático pode observar; tela na maioria; e a laparotomia se fecha com small bites, sutura contínua e fio 4 vezes a incisão.

1. **Indireta:** lateral aos vasos epigástricos, anel profundo; a mais comum.
2. **Direta:** medial, triângulo de Hesselbach, fáscia transversal fraca.
3. **Femoral:** abaixo do ligamento; mulher idosa; sempre operar.
4. **Lichtenstein** ou **TEP/TAPP**; laparoscopia na mulher e na bilateral.
5. **Umbilical maior que 1 cm:** tela pré-peritoneal.
6. **Incisional eletiva:** fechar o defeito e tela retromuscular.
7. **Small bites:** 5 mm × 5 mm, só aponeurose, contínua, ≥ 4:1.
8. **Sinais de sofrimento:** não reduzir; cirurgia de urgência.

Tipos especiais

Nome	Conteúdo
Richter	Parte da parede da alça
Littré	Divertículo de Meckel
Amyand	Apêndice (inguinal)
De Garengeot	Apêndice (femoral)

Pegadinha

A femoral é mais comum na mulher, mas a hérnia mais comum na mulher é a inguinal indireta.

Checklist antes da prova

- ☐ Desenho o canal e o Hesselbach
- ☐ Diferencio direta, indireta e femoral
- ☐ Sei quando observar e quando operar
- ☐ Sei os passos do Lichtenstein
- ☐ Sei as posições da tela
- ☐ Faço o fechamento em small bites
- ☐ Reconheço a hérnia estrangulada